

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
ESCOLA DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA VIDA
MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E SAÚDE

Emanuel Soares Marques Venancio

**AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL EM PACIENTES COM DOENÇA
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) DURANTE INTERNAÇÃO
HOSPITALAR**

Goiânia

2026

Emanuel Soares Marques Venancio

**AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL EM PACIENTES COM DOENÇA
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) DURANTE INTERNAÇÃO
HOSPITALAR**

Defesa de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais e Saúde - nível Mestrado, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás para obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais e Saúde.

Orientadora: Profª Drª Valéria Bernadete Leite Quixabeira

Coorientador: MSc. Bruno Renan de Assis

Goiânia

2026

Catálogo na Fonte - Sistema de Bibliotecas da PUC Goiás

M357a Marques, Emanuel Soares

Autopercepção da saúde integral em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) durante internação hospitalar / Emanuel Soares Marques Venancio.-- 2026.
43 f.: il.

Orientador: Profa. Dra. Valeria Bernadete Leite Quixabeira.

Dissertação (mestrado) -- Pontifícia Universidade Católica de Católica de Goiás, Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e Biomédicas, Goiânia, 2026.

Inclui referências: f. 37-42.

1. Pneumopatias obstrutivas - autopercepção. 2. Pneumopatias obstrutivas - Qualidade de vida. I. Quixabeira, Valéria Bernardes Leite. II. Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Saúde - 31/03/2026. III. Título.

CDU: 616.24(043)

Melany Barbosa Borges Xavier / CRB1 - 1356



DISSERTAÇÃO DO MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E SAÚDE
DEFENDIDA EM 31 DE MARÇO DE 2026 E CONSIDERADA APROVADA PELA
BANCA EXAMINADORA:

Dra. Valéria Bernadete Leite Quixabeira
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Presidente)

Dra. Luciana Carvalho Silveira
Universidade Federal de Goiás (Membro Externo)

Dr. Paulo Roberto De Melo Reis
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Membro)

Dra. Rosana Pereira Moraes
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Suplente)

DEDICATÓRIA

Dedico esta dissertação primeiramente a Deus, fonte de toda sabedoria, força e sustento, que me conduziu com graça e misericórdia ao longo desta caminhada acadêmica.

À Minha Esposa e a minha família, pelo amor, apoio incondicional, compreensão e incentivo constante nos momentos de desafios e conquistas.

À minha orientadora e ao meu Co-orientador por todo auxílio no processo.

E a todos que, de alguma forma, contribuíram para que este sonho se tornasse realidade.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, autor da minha vida e sustento da minha caminhada, por Sua infinita graça, misericórdia e fidelidade. Em cada momento de dificuldade, incerteza e cansaço, encontrei em Sua presença força para continuar. Esta conquista é, antes de tudo, testemunho do cuidado e da providência do Senhor sobre minha vida.

“Até aqui nos ajudou o Senhor.”

À minha Esposa e minha Família, expresso minha mais profunda gratidão pelo amor, apoio e compreensão incondicionais ao longo desta caminhada. À minha Esposa pela paciência, orientação e apoio durante todo processo, sendo meu alicerce, e aos meus pais e irmãos por toda educação e apoio.

À minha orientadora, minha sincera gratidão pela confiança, paciência (principalmente), dedicação e valiosas contribuições acadêmicas. Sua orientação foi essencial não apenas para a construção desta dissertação, mas também para meu crescimento profissional e intelectual e, ao meu Co-orientador por todo apoio e auxílio, ajudas e puxões de orelha durante esse processo.

Aos professores, colegas e amigos que compartilharam conhecimentos, experiências, incentivo e apoio durante esta jornada. Cada contribuição, palavra de encorajamento e gesto de amizade teve importância significativa neste processo.

À instituição de ensino e a todos os profissionais que, direta ou indiretamente, colaboraram para a realização desta pesquisa e para minha formação acadêmica.

À CAPES por ter me dado a oportunidade de iniciar esse sonho e finalizá-lo.

Concluir este mestrado representa mais do que uma conquista acadêmica; representa a materialização de um propósito construído com esforço, renúncia, perseverança e, sobretudo, fé em Deus.

RESUMO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é condição respiratória progressiva associada a elevada morbimortalidade e impacto significativo na qualidade de vida. Durante a internação por exacerbação aguda, ocorre intensificação dos sintomas físicos e maior vulnerabilidade emocional, podendo influenciar a autopercepção da saúde e os desfechos clínicos. Este estudo teve como objetivo analisar a autopercepção física, emocional e social de indivíduos com DPOC durante internação hospitalar por exacerbação. Trata-se de estudo descritivo, transversal, com abordagem qualitativa e quantitativa, realizado com 40 pacientes internados em hospital público estadual entre abril e agosto de 2025. Utilizou-se o *Chronic Respiratory Questionnaire* (CRQ), composto por 20 itens distribuídos nos domínios dispneia, fadiga, função emocional e autocontrole. Observou-se comprometimento multidimensional da autopercepção, com medianas de 3,0 pontos em todos os domínios, indicando impacto moderado a relevante. As atividades mais limitadas pela dispneia foram tomar banho (97,5%), caminhar distâncias moderadas ou longas (80%) e vestir-se (72,5%). Houve diferença estatisticamente significativa entre os sexos no escore total do CRQ ($p = 0,004$), com pior percepção entre mulheres. A taxa de reinternação foi de 22,5% e a mortalidade de 10%. Conclui-se que pacientes hospitalizados por exacerbação da DPOC apresentam importante comprometimento da saúde integral, especialmente nos aspectos funcionais e emocionais, sendo a autopercepção potencial marcador clínico para planejamento de intervenções individualizadas e estratégias de alta hospitalar.

Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Qualidade de Vida; Autopercepção de Saúde.

Sumário

1 INTRODUÇÃO	9
2 REFERENCIAL TEÓRICO	11
2.1 Definição e características clínicas da DPOC	11
2.2 Fatores de risco e Etiologia	12
2.3 Exacerbações da DPOC	13
2.4 Qualidade de Vida	14
2.5 Saúde integral e Autopercepção da Saúde	16
2.6 Autocuidado e Educação em Saúde	17
2.7 Fatores emocionais	18
2.8 Lacunas identificadas	18
3 MATERIAIS E MÉTODOS	18
3.1 Critérios de inclusão	20
3.2 Critérios de exclusão	20
3.3 Aspectos éticos	20
4 RESULTADOS.....	20
4.1 Caracterização da amostra	21
4.2 Desfechos Clínicos.....	23
4.3 Escore Total do Questionário CRQ	25
4.4 Análise dos domínios do CRQ.....	26
5 DISCUSSÃO	28
5.1 Dispneia, Fadiga e Limitação Funcional.....	29
5.2 Função emocional	32
5.3 Diferença entre sexos	33
5.4 Reinternações e mortalidade.....	35
5.5 Limitações do estudo	36
6 CONCLUSÃO.....	37
7 REFERENCIAS	39

1 INTRODUÇÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição respiratória prevalente, caracterizada por limitação persistente do fluxo aéreo e associada a elevada morbimortalidade, sobretudo em países de baixa e média renda. Trata-se de uma doença progressiva que compromete a função pulmonar e impacta significativamente a capacidade funcional e a qualidade de vida dos indivíduos acometidos ^{1,3}.

Os pacientes com DPOC frequentemente apresentam dispneia, fadiga, redução da tolerância ao esforço e dificuldades para realizar atividades de vida diária. Esses sintomas tendem a agravar-se ao longo do tempo, favorecendo limitação funcional, dependência crescente e maior vulnerabilidade a exacerbações. As exacerbações, por sua vez, aumentam o risco de hospitalização, diminuem a estabilidade clínica e contribuem para o declínio da saúde física e emocional desses indivíduos. A hospitalização por exacerbação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) representa um momento de instabilidade clínica, sofrimento físico e vulnerabilidade emocional para o paciente. Nesse contexto, a forma como o indivíduo percebe sua própria condição de saúde pode influenciar diretamente sua adesão ao tratamento, o autocuidado e o risco de reinternações ^{1,4,5}.

A DPOC apresenta elevada prevalência global. Estimativas baseadas em grandes estudos epidemiológicos, como o estudo BOLD, indicam uma prevalência aproximada de 10,3% na população com idade igual ou superior a 40 anos, com intervalo de confiança de 95% entre 8,2% e 12,8%. Projeções epidemiológicas indicam ainda que o número de casos de DPOC em indivíduos com 25 anos ou mais poderá aumentar cerca de 23% entre 2020 e 2050, alcançando aproximadamente 600 milhões de pessoas em todo o mundo, com crescimento mais expressivo entre mulheres e em países de baixa e média renda ¹.

Doenças respiratórias representam um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil, especialmente em razão de sua alta incidência, complexidade clínica e impacto socioeconômico. De acordo com dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), foram registradas, de janeiro a dezembro de 2025, foram registradas 99.134 internações hospitalares por doenças do aparelho

respiratório em todo o território analisado, compreendendo os diagnósticos classificados da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), correspondente aos códigos J00 a J99, relacionados às infecções e demais doenças do aparelho respiratório. Desse total, 52.483 internações ocorreram entre indivíduos do sexo feminino e 46.651 entre indivíduos do sexo masculino^{6, 7}.

Estudos recentes indicam que o risco e a evolução da DPOC não estão restritos a fatores clínicos isolados, mas também a variáveis socioeconômicas, funcionais e perceptivas. Modelos preditivos contemporâneos demonstram que aspectos como autoavaliação de saúde, função cognitiva e condições sociais influenciam significativamente a progressão da doença, reforçando a importância de uma abordagem integral do paciente⁸.

A adesão ao tratamento farmacológico constitui elemento central no manejo da DPOC, estando associada à redução de exacerbações, hospitalizações e mortalidade. Evidências nacionais demonstram que pacientes não aderentes apresentam risco significativamente maior de óbito, ressaltando a importância de compreender fatores que influenciam o comportamento terapêutico. Estudos indicam que, em indivíduos com DPOC, a autopercepção de saúde está fortemente associada à intensidade dos sintomas, à limitação funcional e à presença de sintomas depressivos, evidenciando seu caráter multidimensional⁹.

Nesse contexto, a autopercepção de saúde emerge como um componente relevante para o acompanhamento clínico. A forma como o paciente percebe seus sintomas, limitações e capacidade funcional influencia diretamente sua adesão ao tratamento, busca por cuidados, engajamento em mudanças de estilo de vida e capacidade de autocuidado. Evidências apontam que indivíduos com DPOC podem apresentar percepção distorcida ou limitada de seu próprio estado de saúde, especialmente em períodos de instabilidade clínica, o que pode repercutir negativamente tanto na qualidade de vida quanto na prevenção de novos episódios de exacerbação^{1,10,12}.

Estudos demonstram que indivíduos com DPOC apresentam pior autopercepção de saúde e menor satisfação com a vida, evidenciando que o impacto da doença transcende parâmetros clínicos objetivos¹³. Apesar dos avanços na compreensão da DPOC, ainda há escassez de estudos que investiguem a autopercepção de saúde

durante a internação por exacerbação aguda, momento crítico em que sintomas se intensificam e o impacto emocional e social pode ser mais evidente. Compreender como o paciente vivencia sua condição nesse período pode auxiliar no planejamento de intervenções mais efetivas, centradas no indivíduo e alinhadas ao cuidado integral^{1,14,15}.

Diante disso, este estudo tem por objetivo analisar a autopercepção física, emocional e social de indivíduos com DPOC durante a internação por exacerbação, a fim de compreender seu estado de saúde integral e contribuir para estratégias de cuidado mais individualizadas e orientadas às necessidades reais desses pacientes.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Definição e características clínicas da DPOC

A DPOC é uma condição prevenível e heterogênea, caracterizada pela limitação do fluxo aéreo, acometendo a função pulmonar associada principalmente a respostas inflamatórias anormais. Geralmente, a doença é progressiva, decorrente de resposta inflamatória crônica anormal das vias aéreas e dos pulmões, devido a inalação de partículas e gases nocivos, gerando inflamação nas pequenas vias aéreas (bronquiolite respiratória) e destruição parenquimatosa (enfisema)^{1,16}.

A resposta inflamatória na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um processo fisiopatológico central e complexo, caracterizado por uma amplificação da resposta inflamatória normal das vias aéreas a irritantes crônicos, como a fumaça do cigarro. Esta inflamação é persistente, mesmo após a cessação do tabagismo, e afeta múltiplos compartimentos do pulmão, incluindo as vias aéreas centrais e periféricas, o parênquima pulmonar e a vasculatura^{1,17}.

O infiltrado inflamatório é composto por um aumento de macrófagos, neutrófilos ativados e linfócitos T CD8+. Essas células, juntamente com células estruturais, liberam uma variedade de mediadores inflamatórios, como citocinas e quimiocinas, que perpetuam a inflamação e induzem as alterações estruturais características da doença, como a fibrose peribronquiolar e a destruição da parede alveolar¹. Um subgrupo de pacientes pode apresentar um padrão inflamatório com predominância de eosinófilos, o que configura um fenótipo específico e um "trait" tratável, com implicações diretas na resposta à terapia com corticosteroides inalatórios^{1,18}.

O conceito de *treatable traits* (características tratáveis), incorporado pela diretriz GOLD, propõe uma abordagem individualizada para o manejo da DPOC, reconhecendo sua natureza heterogênea. Essa estratégia baseia-se na identificação de características clínicas, funcionais e biológicas específicas de cada paciente que podem ser modificadas por intervenções direcionadas. Dessa forma, o tratamento deixa de ser centrado apenas no diagnóstico da doença e passa a focar em componentes tratáveis, como inflamação, broncoconstrição, exacerbações e comorbidades, promovendo maior precisão terapêutica e melhores desfechos clínicos ¹.

Segundo a Diretriz da Iniciativa Global para doença pulmonar obstrutiva crônica (GOLD) de 2025, a DPOC deve ser considerada e compreendida como uma síndrome complexa, ocasionada por diversas manifestações clínicas e causas, que resulta principalmente de interações entre fatores genéticos, ambientais e pelo tempo de exposição, que mostra que a DPOC também é uma soma dinâmica de fatores genéticos ambientais e do envelhecimento ¹.

2.2 Fatores de risco e Etiologia

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da doença, como, exposição à poluição da atmosfera e poluição doméstica, que envolve biomassa e poluentes industriais, fatores ocupacionais como poeiras, gases e vapores químicos; baixo desenvolvimento pulmonar na vida precoce; infecções respiratórias recorrentes no período da infância; mudanças climáticas que foram reconhecidas como influenciadores de exacerbações em indivíduos, e fatores genéticos, como a deficiência de alfa-1 antitripsina ¹.

A fisiopatologia da doença envolve inflamação crônica, remodelamento das vias aéreas e destruição do tecido pulmonar, resultando em comprometimento da mecânica respiratória ^{1,19}.

Estruturalmente, a DPOC resulta da combinação entre bronquite crônica, frequentemente associada à bronquiolite das pequenas vias aéreas, e enfisema pulmonar. A inflamação crônica dos bronquíolos promove fibrose peribronquiolar, espessamento da parede brônquica, hipertrofia da musculatura lisa e aumento da produção de muco, levando à redução do calibre das vias aéreas e à limitação do fluxo aéreo ^{1,17,20}.

Além disso, o enfisema pulmonar caracteriza-se pela destruição das paredes alveolares decorrente do desequilíbrio entre proteases e antiproteases, o que resulta em perda do recolhimento elástico pulmonar. Essa alteração favorece o colapso precoce das pequenas vias aéreas durante a expiração e contribui para o aprisionamento de ar, um dos principais mecanismos fisiopatológicos da DPOC ^{1,4,21}.

O diagnóstico presumido de DPOC em unidade de emergência deve ser considerado em indivíduos com histórico de exposição prolongada a gases nocivos, sendo o tabagismo crônico o fator mais comum. Esses pacientes podem apresentar achados sugestivos em radiografia de tórax, além de dispneia progressiva, tosse crônica e persistente e aumento da produção de secreção das vias aéreas. Tais manifestações tendem a evoluir de forma gradual ao longo dos dias ^{1,16}. Para estabelecer o diagnóstico de DPOC, é realizado o exame de espirometria, que deve demonstrar a presença de obstrução persistente do fluxo aéreo, definida pela relação $VEF1/CVF < 0,7$ após o uso de broncodilatador ¹.

2.3 Exacerbações da DPOC

As exacerbações correspondem a episódios agudos caracterizados por piora sustentada dos sintomas respiratórios, com aumento da dispneia, inclusive em repouso, intensificação da tosse e maior produção de secreção das vias aéreas. As infecções respiratórias constituem a principal causa desses eventos, sendo responsáveis por aproximadamente 70% dos casos ^{1,16,22}.

As causas de agudização são frequentemente desencadeadas por infecções respiratórias de origem viral ou bacteriana, podendo ocorrer de forma concomitante. As infecções virais representam os desencadeantes mais comuns, sendo frequentemente associados o rinovírus, vírus influenza, parainfluenza e metapneumovírus. Episódios relacionados a vírus tendem a apresentar maior gravidade, duração prolongada e maior taxa de hospitalização. Já as infecções bacterianas são sugeridas principalmente quando há aumento do volume do escarro e alteração de sua coloração para aspecto purulento, desempenhando papel relevante sobretudo em exacerbações mais graves ^{1,20}.

Essas exacerbações demandam identificação precoce, a fim de possibilitar a instituição de tratamento mais eficaz. Seu manejo é multidimensional e envolve abordagem farmacológica com uso criterioso de antibióticos e corticosteroides

sistêmicos, além de medidas de reabilitação e estratégias voltadas à prevenção de novos episódios ^{16,23,24}.

2.4 Qualidade de Vida

A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um construto complexo e multifatorial, que vai além dos parâmetros clínicos tradicionais de função pulmonar. A literatura aponta que a percepção de bem-estar desses indivíduos é profundamente influenciada pela interação entre limitações físicas, aspectos psicossociais e a capacidade de adaptação à doença ^{25,26}.

De acordo com Hurst *et al.*, as exacerbações afetam a capacidade funcional, um componente chave da qualidade de vida. De acordo com os autores, pacientes que sofrem exacerbações relatam um impacto negativo em atividades cotidianas como caminhar, dormir e falar. Além disso, a hospitalização por uma exacerbação está associada a um declínio físico e funcional que persiste mesmo após a alta hospitalar, afetando a capacidade de exercício e a força muscular. Isso cria um ciclo vicioso, onde a redução da atividade física leva a mais fraqueza e isolamento, realimentando a piora da qualidade de vida ²⁷.

Pacientes com DPOC apresentam dificuldades em atividades da vida diária, além de apresentar redução da força muscular e equilíbrio que podem aumentar o risco de quedas nesses indivíduos. A DPOC está fortemente ligada ao risco de quedas, principalmente devido ao prejuízo no controle postural, resultando em um maior risco de quedas nesses indivíduos, que de forma direta pode impactar a sua qualidade de vida ²⁸. As quedas em pessoas com DPOC estão fortemente associadas a desfechos negativos importantes, como fraturas, internações hospitalares, redução da independência funcional e aumento do risco de mortalidade ^{25,29,30}.

É importante destacar que a qualidade de vida de indivíduos com DPOC é fortemente influenciada por fatores psicológicos, pois apresenta pior qualidade de vida em relação aos indivíduos saudáveis, em decorrência das limitações causadas pela doença. Podendo assim, experimentar sintomas psicológicos associados a essas limitações, como depressão e ansiedade³¹.

Um estudo realizado com 408 indivíduos com DPOC, sendo 294 homens e 114 mulheres sul-asiáticos, compara as diferenças em relação a qualidade de vida e sintomas psicológicos como depressão e ansiedade, evidenciando que, em relação à depressão e ansiedade, mulheres apresentam níveis ligeiramente mais altos de depressão, porém, com menor ansiedade comparado aos homens, e relacionado a qualidade de vida. Os homens tiveram pontuações melhores no aspecto físico, social e ambiental comparado as mulheres, que tiveram piores escores de qualidade de vida, sendo fortemente afetadas pela depressão e ansiedade. O estudo caracteriza que depressão e ansiedade são determinantes centrais da qualidade de vida e da percepção de bem-estar global em pacientes com DPOC, especialmente nas mulheres ³¹.

Considerando o trabalho de Hurst *et al.*, também demonstram que as exacerbações estão fortemente ligadas a problemas de saúde mental. O artigo cita que, após um episódio, é comum o surgimento de sintomas de ansiedade, depressão e até estresse pós-traumático, especialmente em pacientes com exacerbações frequentes ²⁷.

Os autores propõem um modelo de "espiral descendente", onde a exacerbação leva à diminuição da atividade física, gerando inatividade, consequentemente, o indivíduo tende a permanecer mais confinado em casa, causando aumento de sintomas de depressão e ansiedade, que pode ocasionar risco de novas exacerbações ²⁷.

A espiritualidade emerge como um recurso frequentemente utilizado no enfrentamento da DPOC, com efeitos distintos sobre a qualidade de vida. Nascimento *et al.* ³² investigaram o coping religioso e descobriram que a dimensão negativa da espiritualidade, caracterizada por sentimentos de punição ou abandono por uma força superior está associada a piores desfechos, incluindo maior prevalência de sintomas depressivos e menor capacidade funcional ³².

A qualidade do sono é um componente frequentemente negligenciado, mas crucial para o bem-estar global. A má qualidade do sono é altamente prevalente em pacientes com DPOC, estando intimamente relacionada à gravidade da doença e ao pior estado de saúde geral. Os autores concluem que as alterações no sono, como a fragmentação e a redução de suas fases reparadoras, impactam negativamente a

qualidade de vida, adicionando mais um elemento à complexa teia de fatores que determinam o bem-estar desses indivíduos ³³.

2.5 Saúde integral e Autopercepção da Saúde

O Conceito de saúde integral envolve dimensões físicas, mentais, sociais e espirituais, refletindo uma visão ampliada do bem-estar humano. Indivíduos com DPOC tendem a ter uma limitação maior para realização de atividades de vida diária, principalmente quando a doença já está em grau mais avançado ³⁴.

A forma como o indivíduo percebe sua própria condição de saúde pode influenciar sua adesão terapêutica. Pacientes que subestimam a gravidade da doença ou não reconhecem sua vulnerabilidade podem apresentar menor engajamento no tratamento, o que, por sua vez, se associa a maior risco de exacerbações e mortalidade ⁹.

A autopercepção de saúde constitui um elemento central na compreensão do impacto da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) no cotidiano dos indivíduos, pois ultrapassa indicadores clínicos objetivos e incorpora dimensões funcionais, emocionais e sociais da experiência de adoecimento. Embora a DPOC seja caracterizada pela limitação progressiva do fluxo aéreo, conforme descrito pelo *Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease* (GOLD), estudos evidenciam que os pacientes avaliam sua condição de saúde a partir da capacidade de desempenhar atividades significativas no dia a dia. A percepção de dispneia, cansaço e intolerância ao esforço interfere diretamente na realização de atividades de vida diária, atividades instrumentais, trabalho, lazer, sono e participação social, influenciando a forma como o indivíduo julga sua autonomia e qualidade de vida ^{1,35}.

Nessa perspectiva, a autopercepção emerge como avaliação subjetiva do próprio desempenho ocupacional, sendo fundamental para uma abordagem centrada no paciente, como preconiza a *American Occupational Therapy Association*. Ademais, fatores contextuais e ambientais podem intensificar a percepção de limitação ao provocar interrupções nas rotinas e nas ocupações significativas, evidenciando que a autoavaliação de saúde é dinâmica e sensível às condições sociais e ambientais ^{1,23,35}. Dessa forma, compreender a autopercepção do indivíduo com DPOC torna-se indispensável para subsidiar intervenções que considerem não apenas a função

pulmonar, mas o significado atribuído às ocupações e à própria experiência de viver com a doença ^{23,36}.

A dispneia e a fadiga são sintomas frequentes que comprometem o desempenho funcional e a autonomia. Muitas vezes, os familiares não reconhecem as reais dificuldades dessas limitações, e é importante que haja envolvimento familiar e da educação em saúde para melhorar adesão ao tratamento e qualidade de vida. Portanto, o tratamento deve considerar o aspecto biopsicossocial da DPOC, integrando corpo, mente e contexto familiar, ensinando esses indivíduos sobre o autocuidado ^{34,37}.

2.6 Autocuidado e Educação em Saúde

O conceito de autocuidado ainda é pouco difundido e o autocuidado em DPOC ainda é pouco aplicado comparado a outras doenças crônicas. O estudo de Ana Cravo *et al.* mostra que intervenções de autocuidado ajudam pacientes a reconhecer e responder a mudanças nos sintomas, reduzindo hospitalizações e melhorando a qualidade de vida. O estudo ressalta, ainda, que a efetividade dessas estratégias depende da personalização dos planos de cuidado, as quais devem considerar as particularidades clínicas, as condições socioeconômicas e, conforme evidenciado por Younas *et al.* ¹³, os aspectos de saúde mental de cada paciente ^{23,31}.

Assim sendo, a autopercepção em saúde emerge como um componente fundamental. Os pacientes devem ser orientados de forma adequada e objetiva, de forma didática, no momento da alta hospitalar. Essas orientações de autopercepção ajudam pacientes a reconhecer e responder a mudanças nos sintomas, reduzindo hospitalizações e melhorando a qualidade de vida, porém, unidades de saúde ainda não adotam protocolos para orientações desses indivíduos. Essa autopercepção, juntamente com o autocuidado e o monitoramento da doença mostrou-se fortemente associada à melhor qualidade de vida, sendo um componente essencial da autopercepção de saúde integral ³¹.

Considerando os desafios enfrentados pelos sistemas tradicionais de cuidado, surgem formas promissoras de orientação a essa população. O estudo de Zhuang *et al.* demonstra que intervenções digitais são eficazes para aprimorar desfechos subjetivos, incluindo qualidade de vida, autopercepção e dispneia. Além disso, a integração entre tecnologia, equipe multiprofissional e engajamento ativo do paciente

reforça a telessaúde como ferramenta complementar essencial no manejo de doenças crônicas, especialmente quando aliada ao acompanhamento contínuo ³⁸.

2.7 Fatores emocionais

O enfrentamento é o conjunto de estratégias mentais e comportamentais que os indivíduos utilizam para lidar com o estresse e responder a demandas internas ou externas que percebem como superando seus recursos. Sabe-se que em doenças crônicas como a DPOC, os mecanismos de enfrentamento, definidos como estratégias mentais e comportamentais para se ajustar ao estresse e às demandas, são cruciais para gerenciar as limitações físicas, psicológicas e sociais causadas pela doença ¹⁷.

A autoestima é outro recurso psicológico crucial, refletindo a percepção global de autovalor e competência do indivíduo. Em pacientes com DPOC, a autoestima está intimamente ligada ao ajustamento emocional e aos desfechos de saúde: maior autoestima correlaciona-se com menor ansiedade e depressão, melhor adesão ao tratamento e maior participação em reabilitação ^{9,17}.

Estudos mostram que pacientes com DPOC grave podem apresentar sofrimento psicológico, apresentando maiores níveis de ansiedade, maior carga de sintomas e escores mais baixos de autoestima, fortemente ocasionada pela fadiga, dispneia, e limitações funcionais causadas pela DPOC ^{17,39}.

2.8 Lacunas identificadas

Apesar dos avanços, destaca-se a ausência de estudos que avaliem a autopercepção de saúde durante a internação por exacerbação, momento crítico que concentra instabilidade clínica, piora funcional e elevada carga emocional. Poucos trabalhos exploram como o paciente percebe sua condição nesse cenário específico, e essa lacuna dificulta a elaboração de intervenções centradas no paciente e estratégias de alta hospitalar mais eficazes.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa por meio da aplicação do Questionário de Doenças Respiratórias Crônicas (CRQ, na sigla em inglês) em indivíduos internados com quadro de DPOC exacerbado. Após a

aplicação, os dados foram analisados utilizando recursos gráficos e testes estatísticos nos softwares Excel e BioEstat 5.0.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e pela Secretaria Estadual de Saúde, Parecer nº 7.496.824. Foram selecionados pacientes admitidos na unidade hospitalar (Hospital Estadual de Trindade – HETRIN), por demanda espontânea ou via regulação, com diagnóstico médico de DPOC presumido exacerbado confirmado por exames de imagem, avaliação clínica e sintomas característicos da doença, de ambos os sexos e com idade igual ou superior a 40 anos.

Os participantes da amostra não possuíam diagnóstico clínico de DPOC, sendo considerados como DPOC presumido, a inclusão dos pacientes no estudo baseou-se no diagnóstico clínico e de imagem (presumido) por um médico emergencista, o que é uma prática aceita pelas diretrizes Gold e necessária em cenários de agudização, alinhando-se às recomendações de manejo emergencial da diretriz ¹.

Os pacientes foram inicialmente atendidos no pronto-socorro para estabilização do quadro, avaliados clinicamente e posteriormente encaminhados às alas de tratamento, como clínica médica (enfermaria) ou unidade de terapia intensiva (UTI).

O CRQ é um questionário específico para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde em indivíduos com DPOC e foi desenvolvido com o objetivo de mensurar o impacto da doença no cotidiano do paciente. É composto por 20 itens, distribuídos nos domínios de dispneia, fadiga, função emocional e domínio global. As respostas são registradas em escala Likert de 7 pontos, em que 1 indica a pior condição possível e 7, a melhor. O escore total varia de 20 a 140 pontos, sendo que valores maiores indicam melhor qualidade de vida. O tempo médio para aplicação variou entre 15 e 30 minutos.

Todos os participantes foram orientados quanto aos objetivos da pesquisa e às instruções referentes ao preenchimento do questionário. As perguntas foram lidas e explicadas pelo pesquisador, garantindo compreensão adequada e evitando dúvidas durante a aplicação.

A coleta ocorreu no ambiente hospitalar, em local reservado, e incluiu apenas os pacientes que consentiram voluntariamente em participar do estudo. Aqueles que

aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após a assinatura, receberam nova explicação dos itens do questionário para assegurar total entendimento das perguntas. O perfil dos participantes contemplou indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 40 anos, apresentando sinais e história clínica compatíveis com DPOC.

3.1 Critérios de inclusão

- Pacientes internados recentemente por DPOC exacerbado, confirmada por avaliação médica;
- Capacidade de compreensão e comunicação adequadas;
- Ausência de disfunções locomotoras que comprometam a funcionalidade prévia;
- Idade igual ou superior a 40 anos.

3.2 Critérios de exclusão

- Comprometimento neurológico ou cognitivo significativo;
- Doenças graves não controladas;
- Cirurgias prévias ou recentes;
- Pacientes em cuidados paliativos;

3.3 Aspectos éticos

O estudo contou com aprovação institucional do Hospital Estadual de Trindade (HETRIN) e da Secretaria Estadual de Saúde. Após essas autorizações, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e aprovado para início da coleta.

Todos os participantes foram informados sobre os objetivos e procedimentos, assinaram o TCLE e foram esclarecidos de que poderiam desistir da pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo ao seu atendimento.

4 RESULTADOS

Foram avaliados 40 pacientes internados no setor de Clínica Médica (CM) do Hospital Estadual de Trindade (HETRIN), no período de abril a agosto de 2025.

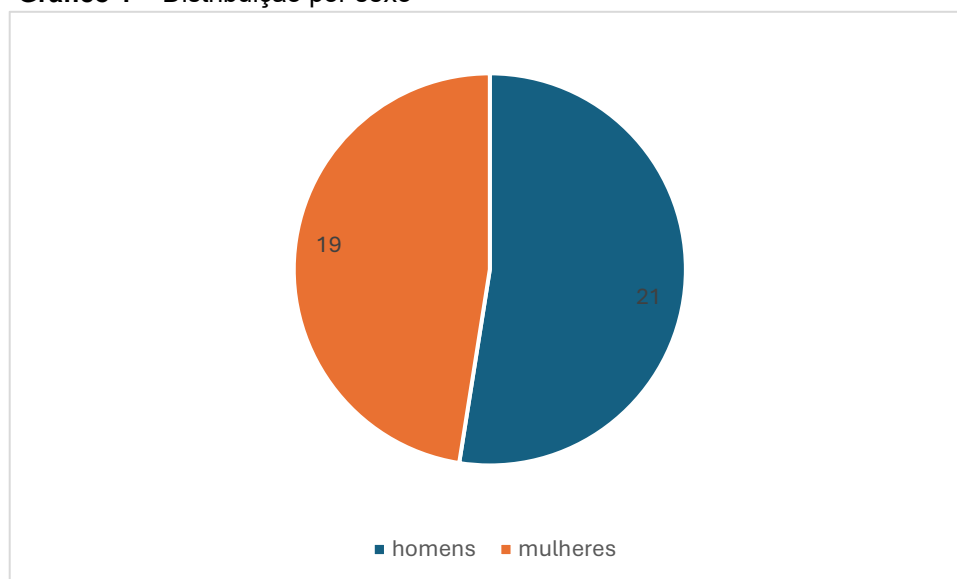
Inicialmente, esses indivíduos deram entrada no pronto socorro da unidade, seja por demanda espontânea ou por regulação.

Após os participantes já estarem com seu quadro clínico estável, eles foram convidados a participar da pesquisa, e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responderam integralmente ao questionário proposto em local adequado e particular.

4.1 Caracterização da amostra

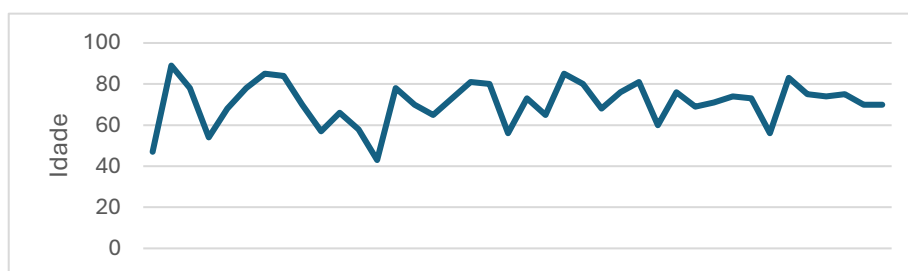
A amostra foi composta por 40 pacientes com DPOC, sendo 52,5% do sexo masculino e 47,5% do sexo feminino, conforme evidenciado no gráfico 1.

Gráfico 1 – Distribuição por sexo



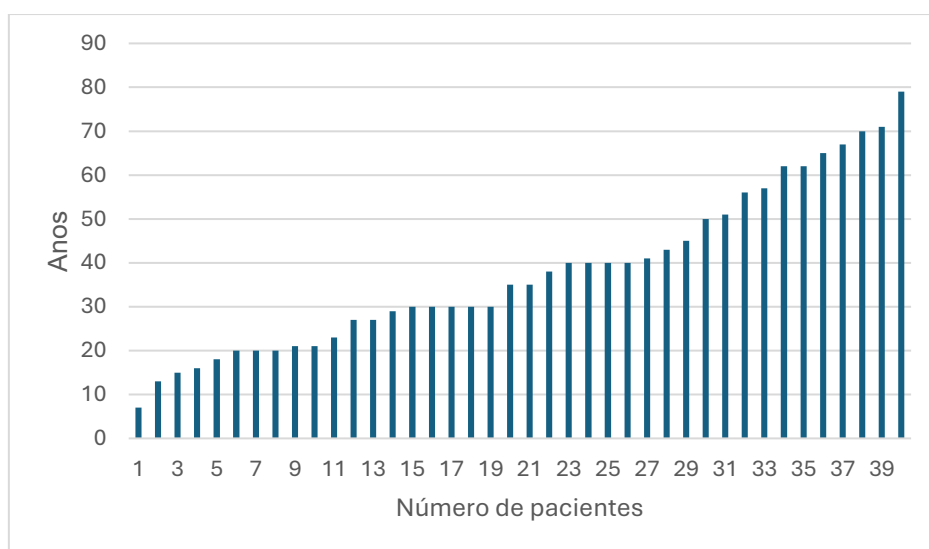
A distribuição da amostra segundo o sexo está apresentada no gráfico, no qual observou-se discreto predomínio do sexo masculino, com proporção semelhante entre os grupos, indicando relativa homogeneidade quanto à variável sexo.

A idade dos participantes variou de 43 a 89 anos, com predomínio de indivíduos idosos, especialmente na faixa etária entre 65 e 85 anos, conforme mostra no gráfico 2.

Gráfico 2 – Faixa etária

Foi identificada uma predominância de indivíduos idosos, especialmente nas faixas etárias mais avançadas, evidenciando o perfil envelhecido da amostra.

O tabagismo foi o principal fator de exposição relatado pelos participantes, estando presente na quase totalidade dos pacientes, como evidenciado no gráfico 3. Em alguns casos, foi relatada a exposição a fogão a lenha por muitos anos, e uma parcela da amostra referiram exposição conjunta de fogão a lenha e cigarro, potencializando o risco respiratório. Registrou-se ainda um caso de associação com uso de crack ou maconha.

Gráfico 3 - Exposição tabágica por anos

O tempo de exposição variou consideravelmente, com relatos entre 7 e mais de 70 anos de tabagismo. Alguns pacientes referiram início do hábito ainda na infância ou adolescência. Foram observadas cargas tabágicas elevadas, incluindo consumo de até duas a três carteiras por dia em determinados indivíduos.

Foi realizada análise de correlação entre os anos de uso de cigarro e a pontuação obtida no questionário CRQ, conforme exposto na Tabela 1. Inicialmente,

aplicou-se o coeficiente de correlação de Pearson, que indicou correlação fraca entre as variáveis ($r = 0,0857$), sem significância estatística ($p = 0,5989$).

Posteriormente, foi calculada a correlação de Spearman, utilizada para avaliar possíveis associações monotônicas entre as variáveis. O coeficiente obtido foi de $-0,0042$, indicando correlação praticamente inexistente entre os anos de tabagismo e a pontuação no CRQ. O valor de p associado a essa análise foi de $0,9795$, evidenciando ausência de significância estatística.

Tabela 1 - Correlação entre anos de uso de cigarro e pontuação no CRQ

Variáveis analisadas	Método de correlação	Coeficiente (r)	p-valor	Interpretação
Anos de uso de cigarro × Pontuação CRQ	Pearson	0,0857	0,5989	Correlação positiva muito fraca, não significativa
Anos de uso de cigarro × Pontuação CRQ	Spearman	-0,0042	0,9795	Correlação praticamente nula, não significativa

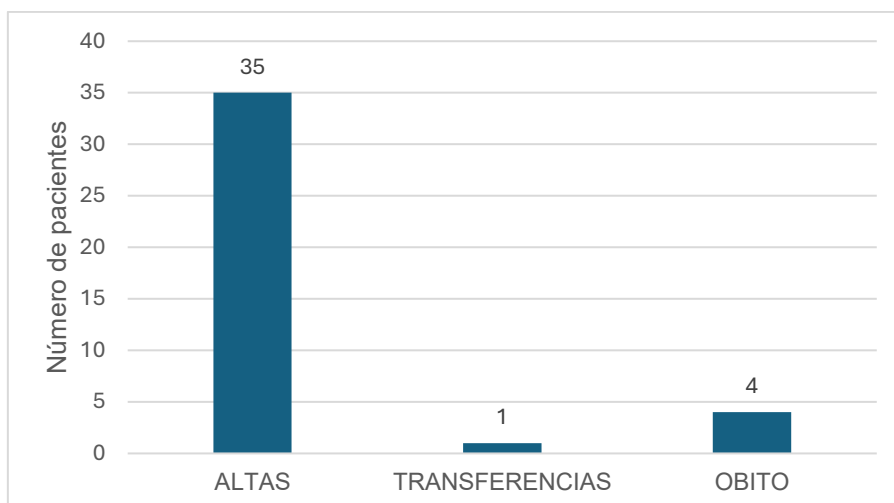
Nota: r = coeficiente de correlação; p = nível de significância estatística.

Assim, tanto a análise de correlação de Pearson quanto a de Spearman não demonstraram associação estatisticamente significativa entre o tempo de uso de cigarro e a pontuação no CRQ na amostra estudada.

4.2 Desfechos Clínicos

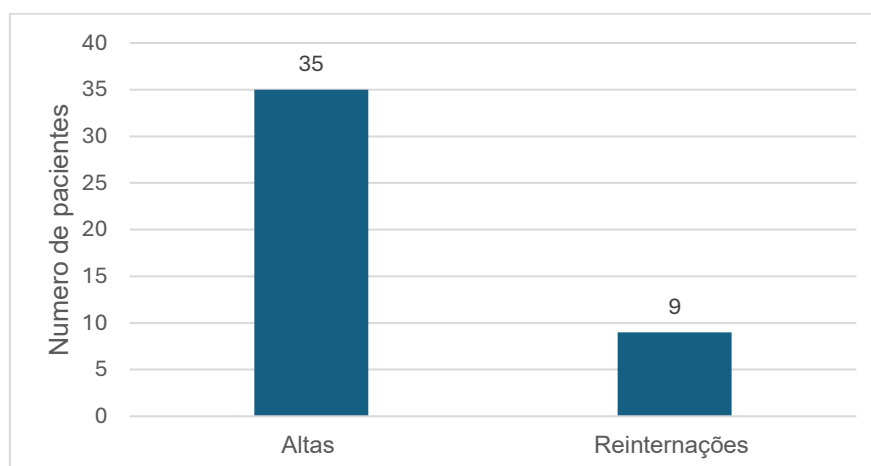
No período analisado, dos 40 pacientes incluídos no estudo, 35 evoluíram para alta hospitalar, correspondendo a 87,5% da amostra, 1 paciente foi transferido da unidade e 4 óbitos. Esse dado exposto no Gráfico 4 indica que a maioria apresentou estabilização clínica suficiente para condições de alta hospitalar segura. Em parte desses casos, a alta ocorreu com necessidade de continuidade do cuidado domiciliar, incluindo uso de oxigenoterapia suplementar e acompanhamento ambulatorial.

Gráfico 4 – Proporção de alta, transferência e óbito.



Na amostra representada, foram identificados nove pacientes com registro de reinternação hospitalar, conforme evidenciado no Gráfico 5, correspondendo a 22,5% da amostra total ($n = 40$). Observou-se que alguns indivíduos apresentaram mais de um episódio de reinternação no intervalo de seis meses, com relato de até seis internações no período.

Gráfico 5 – Índice de reinternações.



Os registros indicam que as reinternações ocorreram predominantemente em pacientes com diagnóstico de doenças respiratórias crônicas, especialmente aqueles com histórico de longa exposição ao tabagismo. A frequência de readmissões hospitalares evidencia a recorrência e a instabilidade clínica observadas em parte da população estudada.

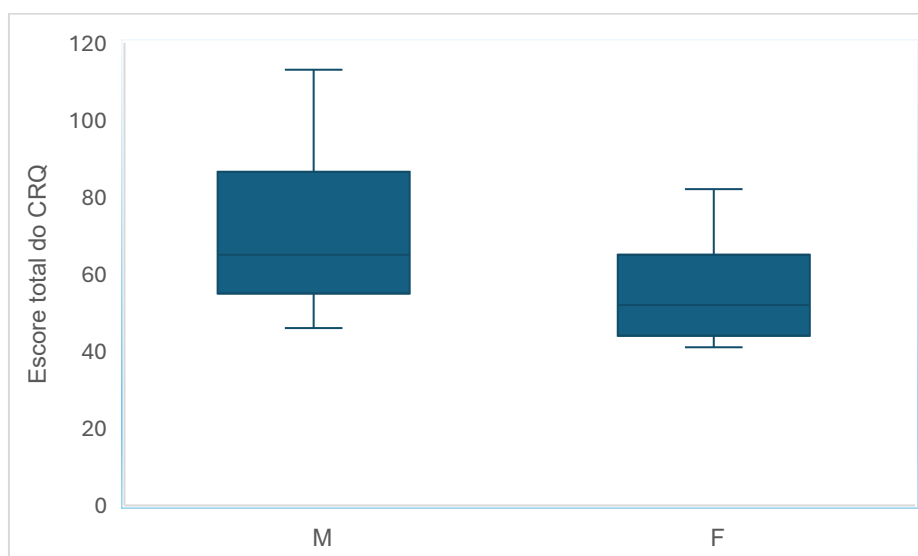
Durante o período de coleta de dados, foram registrados três óbitos hospitalares na unidade, e um óbito após alta hospitalar, correspondendo a uma taxa de mortalidade de 10% da amostra total ($n = 40$). Os óbitos ocorreram no contexto de agravamento do quadro clínico respiratório durante o período hospitalar, evoluindo com descompensação pulmonar e complicações associadas à doença de base, progredindo com instabilidade hemodinâmica importante e óbito.

O escore de qualidade de vida (CRQ) foi semelhante entre os grupos óbito (média = 62,5; mediana = 57) e não óbito (média = 67,6; mediana = 61,5), sem diferença estatisticamente significativa ($p = 0,46$). Em relação ao tempo de tabagismo, o grupo óbito apresentou menor média (26,0 anos; mediana = 24,5) em comparação ao grupo não óbito (41,2 anos; mediana = 30,0), com tendência à significância estatística ($p = 0,07$).

4.3 Escore Total do Questionário CRQ

A qualidade de vida foi avaliada por meio do Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ), cujo escore total pode variar de 20 a 140 pontos, sendo valores mais elevados indicativos de melhor qualidade de vida relacionada à saúde. As pontuações obtidas no instrumento aplicado variaram de 41 a 117 pontos. A maior concentração de valores esteve entre 41 e 94 pontos, sendo a menor de 41 e a maior de 117 conforme evidenciado no Gráfico 6.

Gráfico 6 – Distribuição do escore total do CRQ segundo sexo.



Na comparação entre os sexos, observou-se diferença estatisticamente significativa no escore total do CRQ (Teste de Mann–Whitney, $U = 102$; $p = 0,004$). Pacientes do sexo masculino apresentaram maiores escores (mediana = 65) quando comparados ao sexo feminino (mediana = 53). O tamanho de efeito foi moderado a elevado ($r = 0,45$), isso sugere melhor percepção de qualidade de vida entre homens na amostra estudada conforme exposto na tabela 2.

Tabela 2 - Estatística descritiva do escore total do CRQ segundo sexo ($n = 40$)

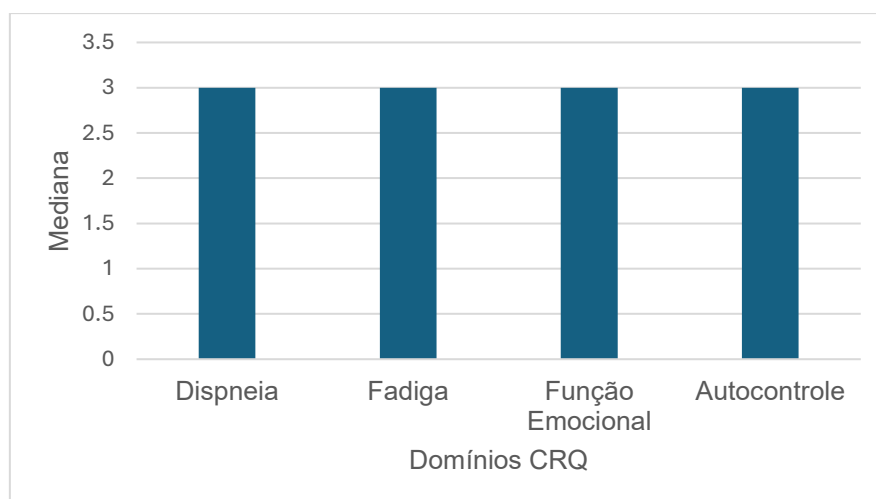
Variável	Masculino ($n = 21$)	Feminino ($n = 19$)	p	r
Mediana (IIQ)	65 (24)	53 (18)	0,004	0,45
Média $\pm$ DP	71 $\pm$ 18	55 $\pm$ 13	—	—
Mín–Máx	53–113	41–82	—	—

4.4 Análise dos domínios do CRQ

O questionário possui 4 domínios específicos, sendo ele dispneia, fadiga, função emocional e autocontrole.

A análise dos domínios específicos do CRQ evidenciou comprometimento multidimensional da percepção de saúde. Todos os domínios apresentaram escores abaixo do ponto intermediário da escala, indicando impacto relevante nas dimensões física e emocional, mostrado no Gráfico 7.

Gráfico 7 - Distribuição das medianas dos domínios avaliados pelo CRQ.



No domínio dispneia, os participantes destacavam 5 atividades do dia a dia que causaram mais dispneia, no qual para cada atividade, era necessário responder o grau de dispneia com base na escala Likert, com resultados de 1 para dispneia muito intensa até 7 para nenhuma dispneia na atividade.

A Tabela 3 mostra que entre as cinco atividades básicas de vida diária como mais limitantes em decorrência da dispneia, foi destacado 3 atividades que foram citadas com maior frequência: tomar banho (n = 39; 97,5%), caminhar distância moderada ou longa (n = 32; 80%) e vestir-se ou trocar de roupa (n = 29; 72,5%).

Tabela 3 – Frequência das 3 atividades mais referidas e pontuações no domínio dispneia (dados não paramétricos)

Atividade	n	Mediana	Intervalo Interquartil (IIQ)	p (Shapiro-Wilk)
Tomar banho	39	2,0	1,5	0,0094
Vestir/trocar roupa	29	3,0	2,0	0,0087
Caminhar dist. moderada/longa	32	2,0	1,0	0,0091

A avaliação da distribuição das variáveis foi realizada por meio do teste de Shapiro-Wilk, que indicou ausência de normalidade para todas as pontuações analisadas ($p < 0,05$). Dessa forma, os dados foram descritos por mediana e intervalo interquartil (IIQ).

As pontuações atribuídas aos itens mais frequentemente referidos indicaram dispneia de intensidade moderada (pontuação 3), caracterizada pela necessidade de interrupções frequentes durante sua realização. Destaca-se que os relatos se concentraram predominantemente em tarefas vinculadas ao autocuidado e mobilidade, componentes essenciais para a manutenção da autonomia e da independência funcional.

A soma total dos 5 itens no domínio dispneia indicaram mediana 3,0 pontos (IIQ = 1,25), indicando a pontuação geral no valor de intensidade moderada, exposto na Tabela 4.

No domínio Fadiga, observou-se mediana de 3,0 pontos (IIQ = 2,0), com valores variando entre 2 e 6. De acordo com os parâmetros do instrumento utilizado, o escore 3 corresponde à categoria “um pouco cansado”, indicando percepção de

cansaço leve a moderado entre os participantes. Considerando que o ponto central da escala é representado pelo valor 4 (neutro), a mediana encontrada sugere tendência a maior percepção de fadiga na amostra. A análise da distribuição dos escores por meio do teste de Shapiro-Wilk evidenciou desvio da normalidade ($p = 0,009$), motivo pelo qual foram adotadas medidas descritivas não paramétricas.

Em relação ao domínio Função Emocional, a mediana foi de 3,0 pontos (IIQ = 2,0), com amplitude de 1 a 6 pontos. Segundo a classificação do instrumento, esse escore corresponde a ocorrência dos sintomas em “boa parte do tempo”, o que indica frequência expressiva de comprometimento emocional entre os participantes. Assim como no domínio Fadiga, os valores situam-se abaixo do ponto intermediário da escala, sugerindo impacto emocional relevante na população estudada. A distribuição dos dados não apresentou normalidade estatística ($p = 0,009$).

O domínio Autocontrole apresentou mediana de 3,0 pontos (IIQ = 2,25), com variação entre 1 e 7 pontos. O valor mediano corresponde à categoria “boa parte do tempo”, indicando presença frequente de dificuldades relacionadas ao autocontrole. Observa-se, ainda, maior dispersão dos escores nesse domínio quando comparado aos demais, conforme evidenciado pelo intervalo interquartil ligeiramente superior. O teste de normalidade também apontou distribuição não normal ($p = 0,009$).

Tabela 4 - Distribuição dos Escores dos Domínios Avaliados

Domínio	Mediana	IIQ	Mín-Máx	p (Shapiro-Wilk)
Fadiga	3,0	2,0	2-6	0,009
Função Emocional	3,0	2,0	1-6	0,009
Autocontrole	3,0	2,25	1-7	0,009

5 DISCUSSÃO

O Presente estudo teve como objetivo analisar a autopercepção física, emocional e social de indivíduos com DPOC durante a internação por exacerbação aguda, embora o questionário tenha sido aplicado durante a hospitalização, os participantes foram orientados a responder com base na sua condição clínica previamente à exacerbação que motivou a internação. Os resultados demonstram comprometimento relevante em todos os domínios avaliados pelo CRQ, com ponto de destaque para limitações associada a dispneia em atividades básicas de vida diária,

presença frequente de fadiga e impacto emocional expressivo. Observou-se ainda diferença estatisticamente significativa entre os sexos, com menores escores de qualidade de vida entre mulheres, o que reforça a necessidade de abordagens assistenciais individualizadas durante o período de hospitalização e no planejamento da alta.

5.1 Dispneia, Fadiga e Limitação Funcional

As atividades básicas mais referidas como limitantes para os participantes, como tomar banho (97,5%), caminhar por distância moderada a longa (80%) e vestir-se (72,5%) são componentes básicos e essenciais para a autonomia e independência funcional. O resultado obtido evidencia que a frequência dessas limitações mostra que o comprometimento ultrapassa o sintoma respiratório de forma isolada, impactando diretamente a capacidade do indivíduo de realizar tarefas fundamentais do cotidiano. As medianas entre 2 e 3 pontos no domínio dispneia indicam intensidade moderada, com necessidade de interrupções frequentes durante a execução das tarefas.

É importante compreender por que atividades específicas, como tomar banho, são tão limitantes. Do ponto de vista fisiológico, o banho exige elevação dos membros superiores, o que compromete a biomecânica respiratória e recruta a musculatura acessória, aumentando o trabalho ventilatório. Associado a isso, a mudança de temperatura e a umidade do ambiente podem desencadear broncoespasmo em vias aéreas hiperreativas, comuns na DPOC ³⁵.

A fadiga muscular periférica, frequentemente presente nesses pacientes, potencializa a dispneia durante o esforço, criando um ciclo vicioso: o paciente sente falta de ar, interrompe a atividade, torna-se mais sedentário e, conseqüentemente, perde condicionamento, piorando ainda mais sua capacidade funcional ³⁵.

Esse dado é particularmente relevante, pois demonstra comprometimento funcional mesmo em atividades de autocuidado, sugerindo impacto significativo na autonomia e independência. Diferentemente de estudos que avaliam predominantemente desfechos globais de qualidade de vida, seus dados permitem identificar especificamente quais tarefas cotidianas são mais afetadas, conferindo maior precisão clínica à interpretação.

A limitação funcional observada em nossa amostra, particularmente em atividades de autocuidado como tomar banho (97,5%) e vestir-se (72,5%), reflete o que Pescaru *et al.* ¹⁷ identificaram como preditores de estratégias de enfrentamento desadaptativas. Segundo esses autores, maior gravidade da dispneia (mMRC) e menor função pulmonar (VEF1%) foram os preditores mais fortes de enfrentamento esquivativo, criando um ciclo vicioso: a limitação funcional leva ao isolamento e à inatividade, que por sua vez perpetuam o declínio funcional. No contexto da internação por exacerbação, esse ciclo pode estar particularmente exacerbado.

A elevação dos membros superiores recruta músculos da cintura escapular que também participam da respiração, reduzindo sua disponibilidade para auxiliar a ventilação. Associado a isso, o aumento da frequência respiratória favorece a hiperinsuflação dinâmica e o aprisionamento aéreo, agravando a limitação ventilatória. Como resultado, o paciente pode apresentar sensação intensa de dispneia, necessitando interromper a atividade para recuperar o padrão respiratório. Estratégias como a respiração com lábios semicerrados são frequentemente utilizadas, pois geram pressão expiratória positiva, contribuindo para reduzir o colapso das vias aéreas e facilitar a eliminação do ar aprisionado ^{1,40}.

Um estudo de Anandan *et al.* ⁴¹, pacientes com características exacerbadoras apresentam piores escores nos domínios atividades e sintomas, evidenciando e reforçando o ponto de que uma maior carga sintomática está associada a uma limitação funcional progressivo e pior prognóstico, esse achado corrobora com nosso estudo.

A limitação física experimentada por esses indivíduos é potencializada pela fadiga, que atua como uma barreira incapacitante nas Atividades de Vida Diária (AVDs). No domínio Fadiga, a mediana de 3,0 pontos (IIQ = 2,0) indica percepção de cansaço leve a moderado, porém com tendência a maior fadiga que o ponto neutro da escala. Observa-se que pacientes com DPOC apresentam uma autopercepção de desempenho ocupacional significativamente reduzida, sentindo-se mais frágeis e limitados em papéis sociais e domésticos ³⁵. Essa fragilidade percebida pode levar à restrição progressiva da participação social, isolamento e dependência, comprometendo a saúde integral do indivíduo.

O domínio autocontrole do CRQ, que apresentou mediana 3,0 (IIQ=2,25) em nossa amostra, pode ser compreendido como um indicador indireto das estratégias de enfrentamento dos pacientes. Pescaru *et al.*¹⁷ demonstraram que pacientes com maior autoestima (avaliada pela *Rosenberg Self-Esteem Scale*) apresentam maior utilização de enfrentamento focado no problema ($\beta=0,22$; $p=0,036$) e melhor capacidade funcional (TC6M% $\beta=0,23$; $p=0,013$). A baixa percepção de autocontrole observada em nossos pacientes durante a internação pode, portanto, refletir não apenas o momento agudo da doença, mas um padrão mais amplo de enfrentamento que antecede e potencializa a exacerbação, justificando a necessidade de intervenções que fortaleçam a autonomia e a autoeficácia ainda durante a hospitalização.

O estudo Halding e Grov³⁹ destaca que a limitação funcional apresenta associação significativa com pior autopercepção. A incapacidade de realizar atividades básicas ou instrumentais interfere diretamente na autonomia, na identidade social e na percepção de utilidade, o que mostra em nosso estudo.

Quando o indivíduo perde capacidade de executar tarefas cotidianas, há ruptura de papéis sociais e alteração da autoimagem. Dessa forma, a percepção negativa da saúde pode refletir sentimento de dependência e fragilidade, mais do que a gravidade objetiva da doença³⁹.

Durante a internação, essa limitação pode ser intensificada pela própria hospitalização, pelo repouso prolongado e pela dependência de cuidados. Assim, a percepção avaliada nesse contexto pode representar momento crítico de vulnerabilidade³⁹.

Os resultados corroboram evidências de que a intensidade dos sintomas, especialmente dispneia e fadiga, constitui determinante central da autopercepção negativa em indivíduos com DPOC.

Essa compreensão multifatorial da autopercepção encontra respaldo em investigações recentes que ampliam o entendimento da DPOC para além de seus determinantes estritamente fisiopatológicos. Modelos preditivos contemporâneos desenvolvidos para estimar risco de DPOC em populações idosas demonstraram que variáveis como escolaridade, condições socioeconômicas, índice de massa corporal,

função cognitiva e, particularmente, a autoavaliação do estado de saúde influenciam significativamente a ocorrência e progressão da doença ⁸.

Esses achados reforçam que a experiência subjetiva do paciente não representa apenas um reflexo emocional da limitação física, mas pode constituir marcador clínico relevante de vulnerabilidade global, o que sustenta a importância de avaliar a autopercepção durante períodos críticos como a hospitalização, como evidenciando em nossos dados ⁸.

5.2 Função emocional

Os resultados obtidos no presente estudo evidenciam que os participantes apresentaram escores abaixo do ponto intermediário da escala no domínio função emocional (mediana = 3,0; IIQ = 2,0), sugerindo impacto emocional relevante. Embora o instrumento utilizado não permita diagnóstico específico de ansiedade ou depressão, a literatura demonstra que indivíduos com DPOC apresentam maior vulnerabilidade a sintomas ansiosos e depressivos quando comparados à população geral ¹⁵.

Indivíduos com DPOC podem apresentar níveis significativamente mais elevados de ansiedade e menor autoestima do que comparado a indivíduos saudáveis. O estudo de Alshraideh *et al.* ³⁶, evidencia que pacientes com DPOC apresentam uma prevalência de ansiedade significativamente superior à da população geral. A incerteza em relação ao prognóstico e ao manejo dos sintomas é um preditor direto de altos níveis de ansiedade, além da incerteza em relação ao tratamento e à progressão da doença, sendo um dos principais gatilhos para transtornos emocionais, estando diretamente associada a escores elevados de ansiedade.

Um dos achados mais relevantes no estudo de Halding e Grov ³⁹, é a associação significativa entre sintomas depressivos e pior autoavaliação da saúde. Isso sugere que o estado emocional não é apenas consequência da doença, mas parte constitutiva da percepção.

A depressão pode alterar a interpretação dos sintomas, aumentar sensação de incapacidade e reduzir expectativa de melhora. Assim, dois pacientes com gravidade clínica semelhante podem apresentar autopercepções distintas dependendo de seu estado emocional ³⁹.

O estudo brasileiro de Schmitt *et al.* ³⁷ mostra que a funcionalidade familiar é um pilar para a estabilidade emocional. Pacientes que são inseridos em famílias disfuncionais apresentam maior comprometimento da função emocional e maior prevalência de sintomas de depressão e ansiedade. por outro lado, pacientes que percebem sua família como funcional apresentam melhores escores de qualidade de vida, pois o suporte emocional reduz o sentimento de isolamento causado pela limitação física. Esse achado reforça a importância de uma abordagem que inclua a família no processo de cuidado, especialmente no momento da alta hospitalar ³⁷.

Nesse contexto, os achados do presente estudo mostram-se consistentes com evidências prévias que apontam para importante carga emocional associada à DPOC.

5.3 Diferença entre sexos

Embora a DPOC tenha sido historicamente considerada uma doença masculina, ao longo dos anos a prevalência tem se tornado semelhante entre os sexos, com particularidades que merecem atenção ⁴².

Conforme os dados divulgados pelo DATASUS, no ano de 2015 foram internados 117.850 pacientes por conta de doenças respiratórias, sendo 55.980 do sexo feminino e 61.870 do sexo masculino. No decorrer dos anos, houve uma inversão nesses dados, mostrando que no ano de 2025 (janeiro a dezembro) foram internados 99.134 pacientes por doenças do aparelho respiratório, sendo 52.483 do sexo feminino e 46.651 do sexo masculino ⁷.

Mulheres com DPOC têm menor carga tabágica que homens para a mesma gravidade de doença, porém, maior exposição à biomassa doméstica (fogão a lenha), que é fator de risco significativo para mulheres, especialmente não fumantes ^{26,42}.

O presente estudo, evidenciou que houve uma diferença significativa entre sexos ($p = 0,004$; $r = 0,45$), com mulheres apresentando pior percepção de qualidade de vida. Este achado no nosso estudo está alinhado com o resultado obtido no estudo de Lee *et al* ⁴² que demonstrou que mulheres com DPOC tendem a apresentar menor função pulmonar ajustada, menor nível de atividade física e piores escores de qualidade de vida quando comparada aos homens. Essa semelhança de resultados sugere que o sexo feminino pode representar um grupo de maior vulnerabilidade clínica e funcional na DPOC. Possíveis explicações incluem que mulheres podem

apresentar um declínio anual da função pulmonar mais acentuado, mesmo com carga tabágica menor.

A diferença significativa observada entre os sexos em nossa amostra com mulheres apresentando pior percepção de qualidade de vida, pode ser compreendida à luz dos mecanismos psicossociais descritos por Pescaru¹⁷. Esses autores demonstraram que a autoestima e as estratégias de enfrentamento são determinantes centrais da adaptação à DPOC. Considerando que a literatura indica maior prevalência de sintomas ansiosos e depressivos em mulheres com DPOC³¹ é possível que as pacientes do sexo feminino em nossa amostra apresentem não apenas maior limitação funcional percebida, mas também menor autoestima e maior tendência ao enfrentamento esquivo durante o período de exacerbação, o que explicaria os escores mais baixos no CRQ, o que corrobora com os achados de Pescaru¹⁷.

Essa hipótese reforça a necessidade de abordagens terapêuticas sensíveis às diferenças de gênero, conforme sugerido por Pescaru *et al.*¹⁷ ao defenderem programas de reabilitação personalizados.

Pacientes do sexo feminino com DPOC frequentemente apresentam pior qualidade de vida quando comparadas aos homens, resultado da interação de fatores fisiológicos, comportamentais e psicossociais. Estudos demonstram que mulheres tendem a relatar maior intensidade de sintomas respiratórios, especialmente dispneia, o que contribui para maior limitação funcional e impacto nas atividades diárias⁴². Além disso, níveis reduzidos de atividade física e maior sedentarismo podem agravar a limitação funcional e comprometer ainda mais a qualidade de vida desses pacientes⁵.

Aspectos psicológicos também desempenham papel relevante, uma vez que ansiedade, depressão e incerteza relacionadas à doença estão significativamente associadas a piores escores de qualidade de vida em indivíduos com DPOC³⁶. Adicionalmente, fatores como estratégias de enfrentamento da doença e autoestima influenciam a forma como os pacientes lidam com os sintomas e as limitações impostas pela doença, podendo contribuir para maior sofrimento psicológico e pior percepção de saúde¹⁷. Dessa forma, a pior qualidade de vida observada em mulheres

com DPOC parece resultar da combinação de maior carga sintomática, limitações funcionais e maior vulnerabilidade psicossocial.

As diferenças entre sexos observadas em nossa amostra, com mulheres apresentando pior percepção de qualidade de vida (mediana 53 vs 65; $p=0,004$) e maior comprometimento emocional. Esses dados corroboram a literatura internacional. Mathews⁴ em uma revisão abrangente sobre as consequências psicossociais da DPOC, destaca que a depressão maior é mais de duas vezes mais comum em mulheres (18%) do que em homens (7%) com a doença, e os transtornos de ansiedade afetam 56% das mulheres frente a 35% dos homens.

Esses achados reforçam a necessidade de abordagens terapêuticas sensíveis às diferenças de gênero, particularmente no que tange ao suporte psicológico durante e após a internação por exacerbação.

5.4 Reinternações e mortalidade

Os desfechos de reinternação (22,5%) e mortalidade (10%) observados em nossa amostra corroboram a literatura que aponta as exacerbações como eventos críticos na história natural da DPOC. Conforme descrito na revisão de MacLeod *et al.*¹⁸, exacerbações recorrentes estão associadas a um declínio funcional progressivo, pior prognóstico, piora da qualidade de vida e aceleração o declínio funcional pulmonar.

É importante notar que esses desfechos objetivos ocorreram em um grupo de pacientes que, subjetivamente, relatavam intensa limitação para atividades básicas (escore de dispneia entre 2 e 3) e alto impacto emocional (escore 3). Essa convergência entre a percepção negativa da saúde e desfechos clínicos adversos sugere que a autopercepção captada pelo CRQ pode ser um marcador sensível de gravidade e um potencial preditor de desfechos futuros.

A taxa de reinternação de 22,5% em um período relativamente curto (seis meses) e a ocorrência de múltiplas readmissões em alguns pacientes (até seis internações) refletem a instabilidade clínica e a complexidade do manejo desses casos.

As reinternações estiveram associadas à descompensação do quadro respiratório, havendo necessidade de suporte ventilatório invasivo em pelo menos

uma das readmissões. Também foram descritas situações de agravamento clínico progressivo, culminando em reinternação e, em alguns casos, evolução desfavorável.

O estudo de Quiñones⁴³, analisou que o risco de mortalidade em indivíduos com DPOC não ocorre de forma isolada, mas em interação com declínio funcional e pior autopercepção de saúde. Assim, a DPOC contribui para um processo mais amplo de vulnerabilidade clínica, no qual limitações funcionais, carga de doenças associadas e desigualdades sociais modulam o desfecho final.

A literatura aponta que a adesão ao tratamento farmacológico desempenha papel central no controle da doença e na prevenção de exacerbações e reinternações. Editorial publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia destaca que pacientes com DPOC não aderentes apresentam risco significativamente maior de reinternações e mortalidade, aproximando-se do dobro quando comparados aos aderentes, mesmo após ajuste para variáveis clínicas. Além disso, a frequência de exacerbações está diretamente associada ao declínio funcional acelerado, pior qualidade de vida e aumento do risco de óbito ⁹.

Nesse contexto, a autopercepção de saúde pode exercer papel mediador entre a condição clínica e os desfechos prognósticos. A maneira como o indivíduo interpreta sua gravidade, vulnerabilidade e capacidade funcional pode influenciar seu engajamento no autocuidado e na adesão terapêutica. Pacientes que subestimam a progressão da doença ou não reconhecem a importância do tratamento contínuo podem apresentar menor adesão, favorecendo descompensações clínicas e reinternações ^{9,23}.

5.5 Limitações do estudo

O presente estudo apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Em primeiro lugar, o tamanho amostral reduzido (n=40) limita a generalização dos achados para a população mais ampla de pacientes com DPOC.

Além disso, o delineamento transversal não permite estabelecer relações de causalidade entre as variáveis investigadas. Destaca-se também que o diagnóstico foi presumido, sem confirmação por espirometria, conforme preconizado pela diretriz GOLD, embora essa prática seja aceita em cenários de emergência.

A coleta de dados em um único centro hospitalar restringe a extrapolação dos resultados para outras realidades institucionais e regionais. Por fim, o instrumento foi aplicado durante a internação, o que pode ter influenciado as respostas dos participantes em função do estresse e da instabilidade clínica característicos desse período.

Apesar dessas limitações, os achados deste estudo oferecem contribuições relevantes para a compreensão da autopercepção de saúde em pacientes com DPOC exacerbada durante a hospitalização, preenchendo importante lacuna na literatura e fornecendo subsídios para o planejamento de intervenções mais individualizadas e centradas no paciente.

Estudos futuros com delineamento longitudinal, amostras maiores e multicêntricas, incluindo medidas objetivas de função pulmonar e controle de comorbidades, são necessários para aprofundar a compreensão dos fatores associados à autopercepção negativa e seu impacto no prognóstico desses pacientes.

6 CONCLUSÃO

Em síntese, os pacientes com DPOC apresentam uma autopercepção de saúde profundamente comprometida em suas múltiplas dimensões. O comprometimento físico é marcado por limitação significativa em atividades essenciais de autocuidado, como tomar banho e vestir-se, indicando perda de autonomia que vai além do esperado apenas pelos sintomas respiratórios.

A fadiga atua como fator agravante, perpetuando o ciclo de inatividade e declínio funcional. No aspecto emocional, a frequência expressiva de sintomas ansiosos e depressivos percebidos revela uma carga psicológica intensa, que pode distorcer a percepção da própria condição de saúde e comprometer a adesão ao tratamento.

A diferença significativa entre os sexos, com pior percepção entre as mulheres, aponta para a necessidade de recortes de gênero nas abordagens terapêuticas. Por fim, a elevada taxa de reinternação e mortalidade na amostra válida a gravidade clínica desses pacientes e sugere que a autopercepção negativa da saúde pode ser um marcador útil para identificação de maior risco.

Esses achados reforçam a necessidade de uma abordagem verdadeiramente integral durante a internação, que não se limite ao manejo farmacológico da crise aguda, mas que avalie e intervenha sobre a percepção multidimensional do paciente.

Intervenções educativas personalizadas, que considerem as diferenças de gênero e incluam a família no processo, podem contribuir para melhorar a autopercepção de saúde, reduzir reinternações e promover qualidade de vida a longo prazo.

Por fim, conclui-se que a autopercepção de saúde em pacientes com DPOC exacerbada é multidimensional e está profundamente comprometida no contexto da hospitalização. A incorporação da avaliação da percepção do paciente sobre sua própria condição no cuidado clínico cotidiano pode contribuir para o planejamento de intervenções mais individualizadas, que considerem não apenas os aspectos fisiopatológicos, mas também as necessidades funcionais, emocionais e sociais. Essa abordagem integral mostra-se essencial para qualificar a assistência, fortalecer o autocuidado e promover desfechos mais favoráveis a longo prazo.

7 REFERENCIAS

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Estratégia global para o diagnóstico, manejo e prevenção da doença pulmonar obstrutiva crônica: relatório de 2025 [Internet]. Deer Park (IL): GOLD; 2024 [citado 2026 Mar 16]. Disponível em: <https://goldcopd.org/2025-gold-report/>
2. Carvalho da Silva MM, Arcuri JF, Pott H, et al. Health-Related Quality of Life and Daily Physical Activity Level in Patients with COPD- a Cluster Analysis. *COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*. 2022;19(1):309-314. doi:10.1080/15412555.2022.2071244
3. Lin CH, Cheng SL, Chen CZ, Chen CH, Lin SH, Wang HC. Current Progress of COPD Early Detection: Key Points and Novel Strategies. *International Journal of COPD*. Dove Medical Press Ltd. 2023;18:1511-1524. doi:10.2147/COPD.S413969
4. Mathews AM. The Functional and Psychosocial Consequences of COPD. *Respir Care*. 2023;68(7):914-926. doi:10.4187/respcare.10542
5. Horner A, Olschewski H, Hartl S, et al. Physical Activity, Depression and Quality of Life in COPD – Results from the CLARA II Study. *International Journal of COPD*. 2023;18:2755-2767. doi:10.2147/COPD.S435278

6. Brasil M da SS de V em S. *Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Análise Da Situação de Saúde e Desafios Para o SUS*. 2014.
7. Brasil M da SaúdeD de I do S– D. Internações por doenças do aparelho respiratório (CID-10 J00–J99) – Brasil, 2024. Ministério da Saúde. 2025. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/nibr.def>
8. Yang Z, Schooling CM, Lee SY, Kwok MK. Development and validation of the EHS-COPD model to predict sex-specific risk of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in older Chinese adults: Hong Kong's Elderly Health Service Cohort. *Ann Transl Med*. 2022;10(1):4-4. doi:10.21037/atm-21-3270
9. Pereira EDB, de Matos Cavalcante AG. Prescription is not enough: the importance of adherence to pharmacological treatment of COPD. *Jornal Brasileiro de Pneumologia. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia*. 2022;48(1). doi:10.36416/1806-3756/e20220058
10. Pontes ACP, Ramos IF, Azevedo S da S, et al. O impacto do sedentarismo em pacientes com doenças pulmonares crônicas – Efeitos da reabilitação pulmonar no controle da doença. *Journal of Medical and Biosciences Research*. 2025;2(1):1085-1105. doi:10.70164/jmbr.v2i1.544
11. Ritchie AI, Wedzicha JA. Definition, Causes, Pathogenesis, and Consequences of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations. *Clin Chest Med. W.B. Saunders*. 2020;41(3):421-438. doi:10.1016/j.ccm.2020.06.007
12. Qian Y, Cai C, Sun M, Lv D, Zhao Y. Analyses of Factors Associated with Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Review. *International Journal of COPD. Dove Medical Press Ltd*. 2023;18:2707-2723. doi:10.2147/COPD.S433183
13. Adebisi YA, Alshahrani NZ, Kalungi G, Somtochukwu OS, Lucero-Prisno DE. Associations of chronic obstructive pulmonary disease with life satisfaction and self-rated health: quantifying the subjective burden in a population-based study. *Quality of Life Research*. 2026;35(1). doi:10.1007/s11136-025-04112-9
14. Mangueira NM, Lucena Viegas I, De M, et al. *Correlação Entre Parâmetros Clínicos e Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Em Mulheres Com DPOC**

Correlation between Clinical Parameters and Health-Related Quality of Life in Women with COPD. Vol 35. 2009.

15. Souza RCA de, Vieira FC de OS, Costa GMO, Souza KRP de, Siqueira LMG de, Marinho PÉ de M. Activities of daily living in patients with chronic obstructive pulmonary disease with depressive symptoms. *Fisioterapia e Pesquisa*. 2020;27(2):194-201. doi:10.1590/1809-2950/19018827022020
16. Viana RCTP, Pincelli MP, Pizzichini E, et al. Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation in the intensive care unit: clinical, functional and quality of life at discharge and 3 months of follow up. *Rev Bras Ter Intensiva*. 2017;29(1). doi:10.5935/0103-507x.20170008
17. Pescaru CC, Crisan AF, Maritescu A, Tudorache E, Oancea C. A Multidimensional Perspective on COPD: How Coping Styles and Self-Esteem Relate to Psychological Distress and Functional Capacity. *International Journal of COPD*. 2025;20:4143-4157. doi:10.2147/COPD.S561817
18. MacLeod M, Papi A, Contoli M, et al. Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation fundamentals: Diagnosis, treatment, prevention and disease impact. *Respirology. John Wiley and Sons Inc*. 2021;26(6):532-551. doi:10.1111/resp.14041
19. Cukier A, De Godoy I, Costa CH da, et al. Symptom variability over the course of the day in patients with stable COPD in Brazil: A real-world observational study. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2020;46(3). doi:10.36416/1806-3756/e20190223
20. Quadflieg K, Machado A, de Lima FF, et al. Physical status, symptoms and health-related quality of life during a severe exacerbation of COPD: Recovery and discriminative capacity for future events. *Respir Med*. 2023;220. doi:10.1016/j.rmed.2023.107437
21. Camac ER, Voelker H, Criner GJ. Impact of COPD exacerbations leading to hospitalization on general and disease-specific quality of life. *Respir Med*. 2021;186. doi:10.1016/j.rmed.2021.106526
22. Júnior IB, da Costa CC, de Souza RM, Dos Santos ÁH, Teixeira PJZ. Influence of pulmonary rehabilitation in patients with copd exacerbator phenotype. *Jornal*

- Brasileiro de Pneumologia*. 2020;46(6):1-7. doi:10.36416/1806-3756/e20190309
23. Cravo A, Attar D, Freeman D, Holmes S, Ip L, Singh SJ. The Importance of Self-Management in the Context of Personalized Care in COPD. *International Journal of COPD*. Dove Medical Press Ltd. 2022;17:231-243. doi:10.2147/COPD.S343108
 24. da Silva LCC, de Araújo AJ, de Queiroz ÂMD, Sales M da PU, Castellano MVC de O. Smoking control: Challenges and achievements. *Jornal Brasileiro de Pneumologia. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia*. 2016;42(4):290-298. doi:10.1590/S1806-37562016000000145
 25. Puzzi VC, Paes TR, Belo LF, et al. Correlação entre atividades de vida diária e capacidade funcional de membros superiores e inferiores em pacientes com DPOC. *ASSOBRAFIR Ciência*. 2021;12:e41798. doi:10.47066/2177-9333.ac.2020.0023
 26. de Lima C de A, de Oliveira RC, de Oliveira SAG, et al. Quality of life, anxiety and depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Rev Bras Enferm*. 2020;73. doi:10.1590/0034-7167-2019-0423
 27. Hurst JR, Skolnik N, Hansen GJ, et al. Understanding the impact of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations on patient health and quality of life. *Eur J Intern Med. Elsevier B.V*. 2020;73:1-6. doi:10.1016/j.ejim.2019.12.014
 28. Lamezon AC, Cavon BL, Valderramas S. Equilíbrio, quedas e risco de quedas na DPOC: revisão sistemática dos instrumentos de avaliação, propriedades de medida e utilidade clínica. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*. 2024;27. doi:10.1590/1981-22562024027.230189.pt
 29. Oliveira CC, Annoni R, Lee AL, McGinley J, Irving LB, Denehy L. Falls prevalence and risk factors in people with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review. *Respir Med. W.B. Saunders Ltd*. 2021;176. doi:10.1016/j.rmed.2020.106284
 30. Birinci T, Kısa EP, Akıncı B, Kuran Aslan G, Kıyan E. The Investigation of Falls and Balance from the Perspective of Activities of Daily Living in Patients with

- COPD. *COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*. 2021;18(2):147-156. doi:10.1080/15412555.2021.1904867
31. Younas A, Zeb H, Durante A, Vellone E. Sex based differences in depression, anxiety, and quality of life and predictors of quality of life among South Asian individuals with chronic obstructive pulmonary disease: A Bayesian analysis. *Soc Sci Med*. 2024;351. doi:10.1016/j.socscimed.2024.116989
 32. Nascimento FAB do, Silva GPF da, Prudente GFG, Mesquita R, Pereira EDB. Assessment of religious coping in patients with COPD. *J Bras Pneumol*. 2019;46(1):e20180150. doi:10.1590/1806-3713/e20180150
 33. Clímaco DCS, Lustosa TC, Silva MV de FP, et al. Sleep quality in COPD patients: correlation with disease severity and health status. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2022;48(3). doi:10.36416/1806-3756/e20210340
 34. de Vasconcelos RF, Frota MXF, de Albuquerque VB, da Silva Munguba MC. Self-perception of the patient with chronic obstructive pulmonary disease on their occupational performance during the COVID-19 pandemic. *Brazilian Journal of Occupational Therapy*. 2022;30. doi:10.1590/2526-8910.CTOAO22612983
 35. de Vasconcelos RF, Frota MXF, de Albuquerque VB, da Silva Munguba MC. Self-perception of the patient with chronic obstructive pulmonary disease on their occupational performance during the COVID-19 pandemic. *Brazilian Journal of Occupational Therapy*. 2022;30. doi:10.1590/2526-8910.CTOAO22612983
 36. Alshraideh J, Abu Tabar N, Al Qadire M, Thultheen I. Health-Related Quality Of Life, Uncertainty, and Anxiety among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *F1000Res*. 2021;10. doi:10.12688/f1000research.51936.1
 37. Schmitt C, Souza SA de, Brinques C da S, Silva TF da, Silva ALG da, Trimer R. Funcionalidade da família dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. *Fisioterapia e Pesquisa*. 2021;28(2):145-150. doi:10.1590/1809-2950/19033328022021
 38. Zhuang M, Hassan II, Ahmad WMAW, et al. Effectiveness of Digital Health Interventions for Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. *J Med Internet Res*. 2025;27. doi:10.2196/76323

39. Halding AG, Grov EK. Self-rated health aspects among persons living with chronic obstructive pulmonary disease. *International Journal of COPD*. 2017;12:1163-1172. doi:10.2147/COPD.S129325
40. Shah NM, Hart N, Kaltsakas G. Managing breathlessness in end-stage COPD: a neural respiratory drive approach. *J Bras Pneumol*. 2022;48(4):e20220264. doi:10.36416/1806-3756/e20220264
41. Anandan J, Dwivedi DP, Govindaraj V. Clinical phenotypes of COPD and their impact on quality of life: A cross-sectional study. *Respir Med*. 2023;220. doi:10.1016/j.rmed.2023.107452
42. Lee K, Lee HS, Lee KJ, Hong SK, Shin HH, Lee GC. Gender differences in pulmonary function, physical activity, and quality of life of patients with COPD based on data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2015 to 2019 from the Perspective of Pulmonary Rehabilitation. *Medicine (United States)*. 2022;101(44):E31413. doi:10.1097/MD.00000000000031413
43. Quiñones AR, McAvay G, Vander Wyk B, Han L, Nagel C, Allore HG. A Joint Model for Disability, Self-Rated Health, and Mortality Among Medicare Beneficiaries—Differences by Chronic Disease and Race/Ethnicity. *J Aging Health*. 2024;36(10):642-653. doi:10.1177/08982643231210027

ANEXO 1 – QUESTIONARIA CRQ

Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ)

Nome do paciente: _____ Data: ____/____/____

Entrevistador: _____ ID _____

1. DOMÍNIO: DISPNEIA Instruções: Peça ao paciente que identifique 5 atividades do dia a dia que causaram mais falta de ar nas últimas 2 semanas. Para cada uma, pergunte o grau de dispneia (1 = muito intensa, 7 = nenhuma). Atividade (descrita pelo paciente) Grau de falta de ar (1–7)

2. DOMÍNIO: FADIGA Instruções: Pergunte ao paciente sobre o nível de energia nas últimas 2 semanas. Use escala de 1 (muito cansado) a 7 (cheio de energia). Pergunta Escore (1–7)

- Você teve energia suficiente para fazer suas tarefas diárias?

- Sentiu necessidade de deitar ou descansar durante o dia?

- Sentiu-se cansado mesmo sem esforço físico?

- Conseguiu manter-se ativo durante o dia?

3. DOMÍNIO: FUNÇÃO EMOCIONAL Instruções: Pergunte como o paciente se sentiu emocionalmente em relação à dispneia. Pergunta Escore (1–7)

- Você se preocupou com a falta de ar?

- Sentiu medo por causa da sua respiração?

- Sentiu-se envergonhado com a dispneia em público?

- A falta de ar causou tristeza ou desânimo?

- Ficou irritado ou frustrado com sua respiração?

- Evitou atividades por medo da dispneia?

- Sentiu ansiedade por não controlar os sintomas?

4. DOMÍNIO: AUTOCONTROLE Instruções: Avalie o quanto o paciente sente que compreende e controla sua condição. Pergunta Escore (1–7)

- Você sente que consegue controlar sua falta de ar?

- Sabe o que fazer quando tem piora da respiração?

- Sente-se confiante ao lidar com crises respiratórias?

- Tem conhecimento suficiente sobre sua doença pulmonar?

Cálculo dos Resultados (opcional)

Some os escores de cada domínio e divida pelo número de perguntas para obter a média por domínio:

UTILIZA O2 DOMICILIAR? () SIM () NÃO